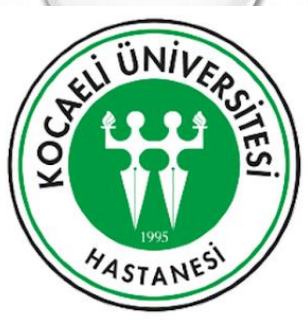




KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

KONU: CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI ÖNLEME GİRİŞİMLERİ VE YÖNETİMİ

SUNAN
ZEYNEP ÖZTÜRK

Kocaeli, 2026

İÇERİK PLANI

1. Cerrahi Alan Enfeksiyonları Önleme Girişimleri ve Yönetimi
2. Kolorektal ve Gastrointestinal Cerrahide Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi

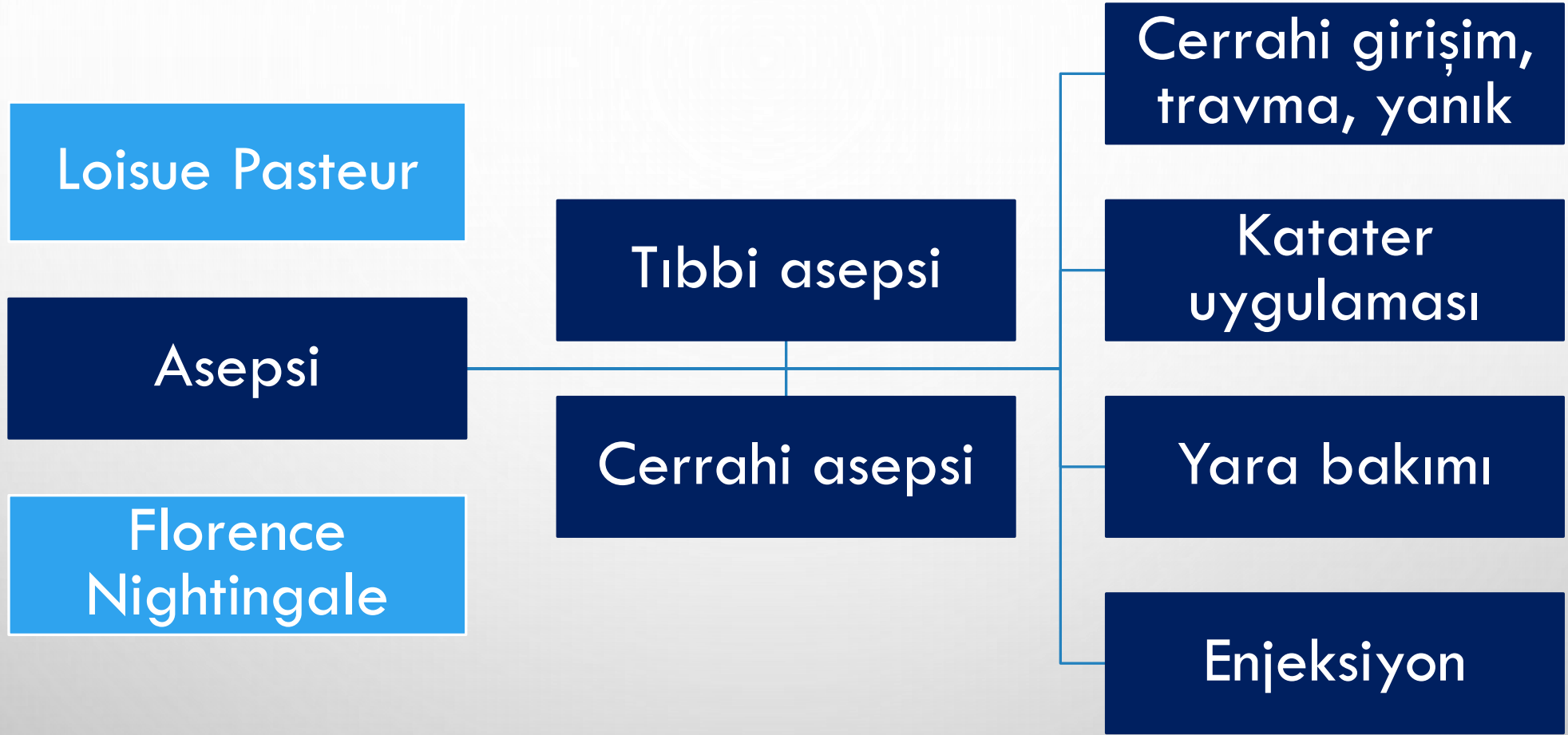


SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR



- CERRAHI ALAN ENFEKSİYONLARI
- KATATER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARI
- ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI
- VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ
- KEMİK VE EKLEM ENFEKSİYONLARI
- KARDİOVASKÜLER SİSTEM ENFEKSİYONLARI
- SANTRAL SINIR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI
- GASTROİNTESTİNAL SINIR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI
- GÖZ, KULAK, BURUN VE BOĞAZ ENFEKSİYONLARI

- CERRAHI ALAN ENFEKSİYONLARI; HASTA VE CERRAHIYE BAĞLI RISK FAKTÖRLERİYLE GELİŞEN, AMELİYAT SONRASI 30–90 GÜN İÇİNDE ORTAYA ÇIKAN VE UYGUN STERİLİZASYON, ASEPSİ, ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ İLE HASTA YÖNETİMİ SAYESİNDE BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖNLENEBİLEN SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARDIR.



Surgical site infection PREVENTION in the PRIMARY HEALTH CARE setting

During surgery

Before surgery



Drapes and gowns



OR room discipline



Click on the icons to access dedicated resources

Environmental cleaning



SAP prolongation



After surgery

Decontamination and reprocessing of medical devices



Wound dressings



General SSI prevention
More resources for the
primary health care setting

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU (CAE)



Cerrahi bir girişime bağlı olarak gelişen; sterilizasyon kurallarındaki eksiklikler ve hastaya ait risk faktörleri (ileri yaş, diyabet vb.) ile ilişkili olabilen ve ameliyat sonrası genellikle **30-90 gün içinde** ortaya çıkan yara enfeksiyonudur.



ETİYOLOJİK NEDENLER

Sterilizasyon kurallarındaki eksiklikler

- Yetersiz sterilizasyon
- Uygun olmayan cerrahi teknik
- Kontamine cerrahi malzeme
- Ameliyathane ortamının yetersizliği



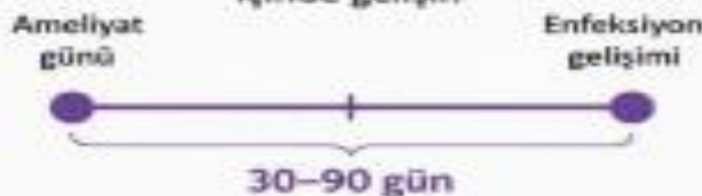
Hastaya ait risk faktörleri

- İleri yaş
- Diyabet mellitus
- Obezite
- Bağışıklık sisteminin baskılanması
- Malnütrisyon
- Sigara kullanımı
- Uzun ameliyat süresi



GELİŞİM ZAMANI

Ameliyatı takiben genellikle **30-90 gün** içinde gelişir.



Eğer protez veya implant kullanılmışsa, enfeksiyon implantın yerleştirilmesini takiben 1 yıl içinde gelişebilir.

KLİNİK BULGULAR

- İnsizyon bölgesinde kızarıklık
- Şişlik
- Ağrı ve hassasiyet
- Isı artışı
- Pürülan akıntı
- Ateş

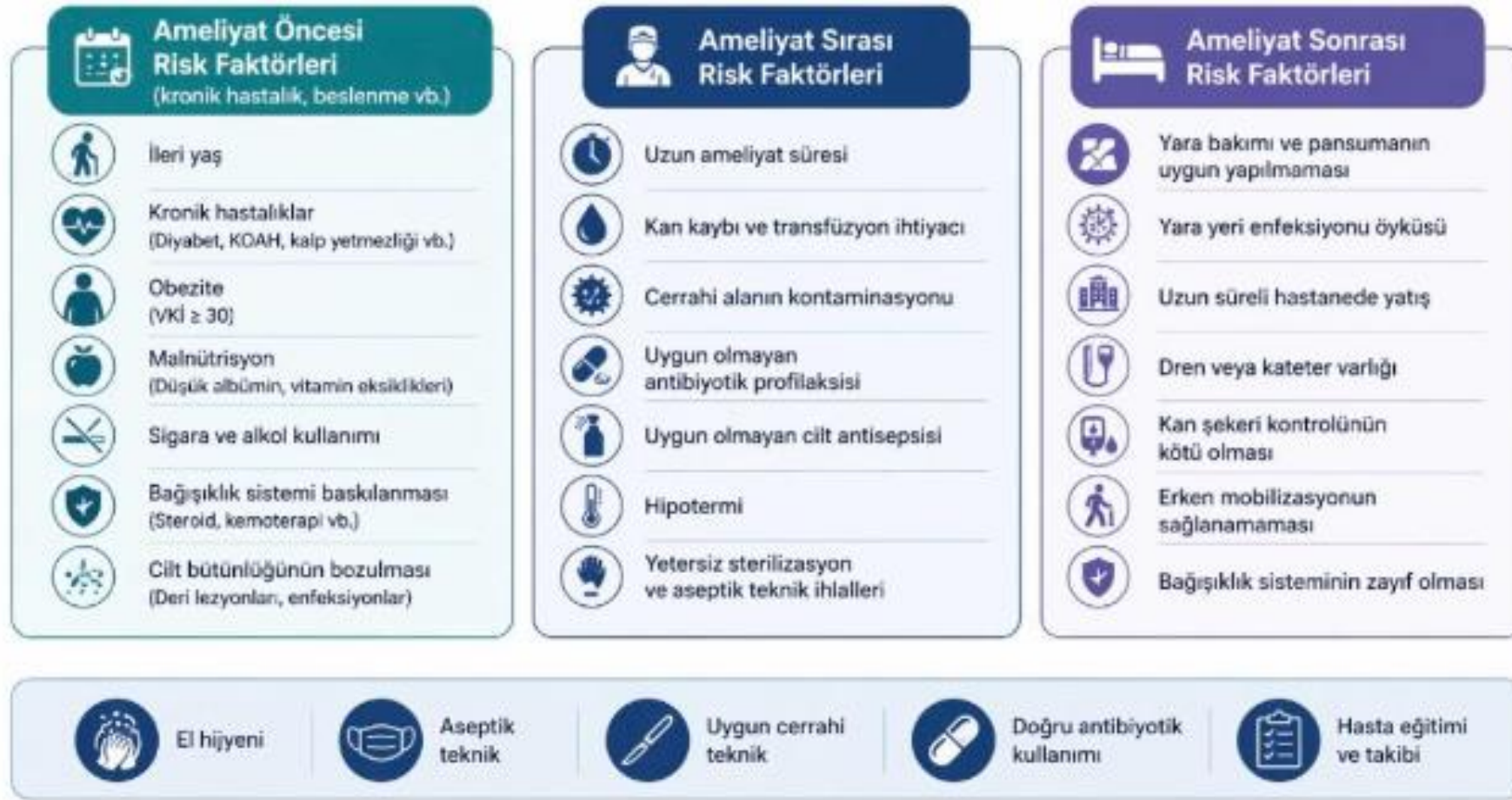
ÖNLEMLER

- El hijyeni
- Uygun preoperatif hazırlık
- Antibiyotik profilaksisi (uygun endikasyon)
- Sterilizasyon ve asepsi kurallarına uyum
- Kan şekeri kontrolü
- Ameliyat süresini azaltma
- Pansuman ve yara bakımı



Cerrahi alan enfeksiyonları hastanede kalış süresini uzatır, maliyeti artırır ve morbidite ile mortaliteye yol açabilir. Uygun önlemlerle büyük ölçüde önlenabilir.

1. CERRAHI ALAN ENFEKSİYONLARI ÖNLEME GİRİŞİMLERİ VE YÖNETİMİ



YARA İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Cerrahi yaralar, enfeksiyon riskini tahmin etmek ve uygun profilaksi, izlem ve bakım stratejilerini belirlemek amacıyla 4 kategoriye ayrılır.

1. TEMİZ (CLEAN) YARA	2. TEMİZ-KONTAMİNE (CLEAN-CONTAMINATED) YARA	3. KONTAMİNE (CONTAMINATED) YARA	4. KİRLİ / ENFEKTE (DIRTY-INFECTED) YARA
			
- Enfeksiyon yoktur. - Solunum, sindirim, üriner veya genital sistem açılmaz. - Aseptik koşullar korunur. - Primer kapatma yapılır.	- Kontrollü şekilde vücut boşluklarına girilir. - Kontaminasyon minimaldir. - Aseptik teknik korunur.	- Açık travmatik yaralar. - Belirgin kontaminasyon vardır. - Gastrointestinal içerik sızıntısı olabilir. - Aseptik teknikte bozulma.	- Mevcut enfeksiyon veya nekrotik doku vardır. - Pürülan (irinli) durum söz konusudur. - Geç müdahale edilen travmalar.
ÖRNEK - Tiroid ameliyatı - Ortopedik cerrahi	ÖRNEK - Safra kesesi ameliyatı - Elektif bağırsak cerrahisi	ÖRNEK - Travmatik yaralar - Bağırsak perforasyonu (erken dönem)	ÖRNEK - Apse drenajı - Peritonit - Gecikmiş travmatik yaralar
ENFEKSİYON RİSKİ %1–2	ENFEKSİYON RİSKİ %3–10	ENFEKSİYON RİSKİ %10–20	ENFEKSİYON RİSKİ %20–40+

KISA ÖZET

1
Temiz

→

2
Temiz-Kontamine

→

3
Kontamine

→

4
Kirli / Enfekte

 **ENFEKSİYON RİSKİ**
KADEMELİ OLARAK ARTAR.

NEDEN PROFİLAKSİ

1. Enfeksiyonları önlemek

- Cerrahi girişimlerde mikroorganizmaların vücuda giriş riski artar.
- Profilaktik önlemler bu mikroorganizmaların çoğalmasını engeller.

2. Morbidite ve mortaliteyi azaltmak

- Cerrahi alan enfeksiyonları hastanede kalış süresini uzatır ve komplikasyon riskini artırır.
- Profilaksi ile bu komplikasyonların görülme sıklığı düşer.

NEDEN PROFİLAKSİ

3. İyileşme sürecini hızlandırmak

- Enfeksiyon gelişmeyen hastalarda yara iyileşmesi daha hızlı olur.* Hastanın normal yaşamına dönüş süresi kısalır.

4. Sağlık maliyetlerini azaltmak

- Enfeksiyon gelişmesi durumunda ek tedaviler (antibiyotik, revizyon cerrahisi vb.) gerekir.

5. Risk faktörlerini kontrol altına almak

- Diyabet, obezite, ileri yaş gibi faktörler enfeksiyon riskini artırır.

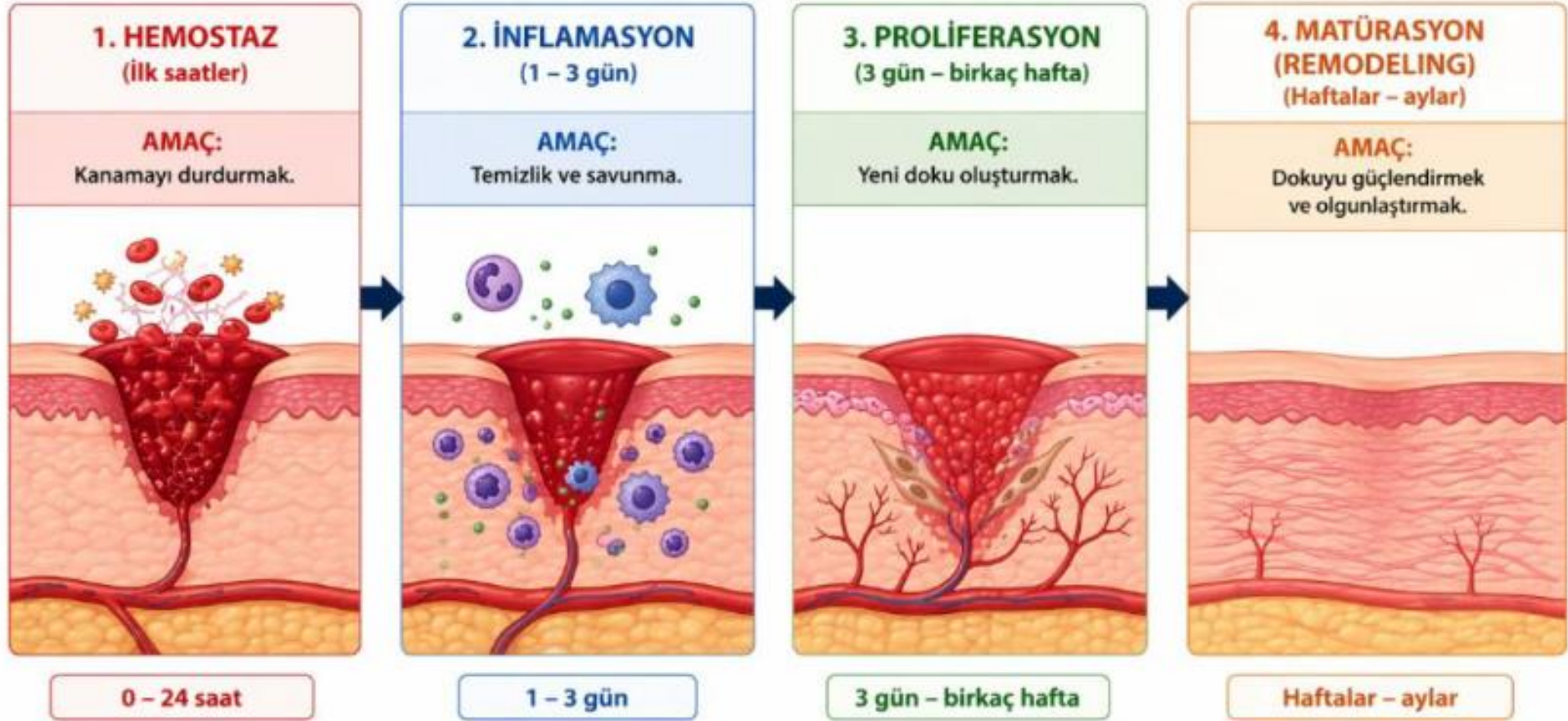
NEDEN PROFİLAKSİ

6. Hastane enfeksiyonlarını azaltmak için

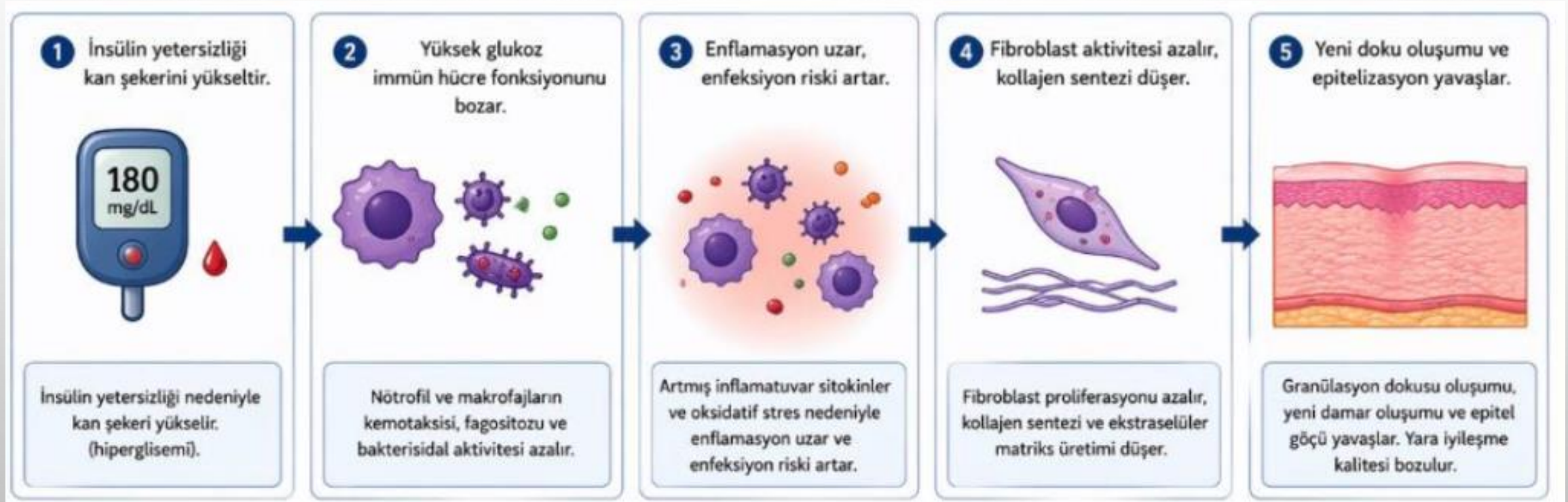
- Profilaktik uygulamalar (asepsi, sterilizasyon, antibiyotik kullanımı) hastane kaynaklı enfeksiyonların yayılmasını önler.

7. Cerrahi başarı oranını artırmak

YARA İYİLEŞME FİZYOLOJİSİ



DIYABETİK HASTALARDA PERIOPERATİF KAN GLİKOZU KONTROLÜ



İYİLEŞME GECİKİR

Doku onarımı ve yeni doku oluşumu yavaşlar.



ENFEKSİYON RİSKİ ARTAR

İmmün yanıt zayıflar, enfeksiyon gelişme olasılığı yükselir.



YARA İYİLEŞME KALİTESİ BOZULUR

Granülasyon doku kalitesi azalır, epitelizasyon yavaş ve zayıf olur.



KRONİK YARA GELİŞİM RİSKİ ARTAR

Yara süreci uzar, kronikleşme ve komplikasyon riski yükselir.

- ✓ İnsülin yetersizliği kan şekerini yükselterek **immün yanıtı zayıflatır**.
- ✓ Yüksek glukoz, nötrofil ve makrofajların fonksiyonunu bozar; enflamasyonu uzatır ve **enfeksiyon riskini artırır**.
- ✓ Fibroblast aktivitesi azalır, **kollajen sentezi** ve ekstraselüler matriks üretimi düşer.
- ✓ Yeni doku oluşumu ve epitelizasyon **yavaşlar**; granülasyon dokusu **zayıf** kalır.
- ✓ Sonuç olarak **yara iyileşmesi gecikir**, iyileşme kalitesi bozulur ve **kronik yara gelişim riski artar**.

BATIN CERRAHISİNDE CAE NEDEN DAHA FAZLA GÖRÜLÜR

- **Bakteriyel flora:** Karın bölgesi, doğal olarak çok sayıda bakterinin bulunduğu bir alandır. Özellikle bağırsaklar, birçok potansiyel patojen barındırır. Cerrahi sırasında bu bakterilerin dışarıya çıkması veya cerrahi alanla temas etmesi enfeksiyon riskini artırabilir.
- **Yara büyüklüğü ve derinliği:** Abdominal cerrahiler genellikle daha büyük ve derin yaralar içerir, bu da enfeksiyon gelişme olasılığını artırır. Yüzeyel yaralar yerine derin dokulara ulaşılması, enfeksiyon riskini artıran bir faktördür.
- **Postoperatif komplikasyonlar:** Batın cerrahisinde, cerrahiden sonra komplikasyonlar (örneğin, anastomoz sızıntıları) yaşanma olasılığı daha yüksektir. Bu tür komplikasyonlar enfeksiyon riskini artırabilir.
- **Operasyon süresi ve teknik:** Uzun süren ve teknik olarak zor olan cerrahiler, enfeksiyon riskini artırabilir. Uzun süren ameliyatlar, dokuların daha fazla travmatize olmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir.



1. SAFRA KESESİ AMELİYATI (KOLESİSTEKTOMİ)

Safra kesesinin çıkarılmasıdır. Genellikle laparoskopik olarak yapılır.

1. YARA TÜRÜ



- Elektif (laparoskopik):

**Temiz-kontamine
(Class II)**

- Akut kolesistit, perforasyon, ampiyem:

Kontamine (Class III)

2. ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ



- Düşük riskli elektif laparoskopik kolesistektomi: Profilaksi genellikle gerekmez.

- Yüksek riskli hastalarda (≥65 yaş, diyabet, akut inflamasyon, safra yolu enfeksiyonu):

➤ Cefazolin 2 g IV (indüksiyondan 30–60 dk. önce tek doz)

- Profilaksi 24 saat içinde kesilmelidir.



Antibiyotik, insizyondan 30–60 dk. önce başlanmalı ve 24 saat içinde kesilmelidir.

3. RİSK FAKTÖRLERİ



- Yaş > 65
- Erkek cinsiyet
- Diyabet mellitus
- Akut kolesistit / safra yolu enfeksiyonu
- Perforasyon, ampiyem
- Uzun operasyon süresi (> 2 saat)
- Obezite
- İmmünsüpresyon
- Perioperatif kanama

4. CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU (CAE) ÖNLEME ÖNERİLERİ



Uygun antibiyotik profilaksisi ve zamanlaması



Ellerin uygun şekilde yıkanması ve aseptik teknik



Normotermi sağlanması (>36 °C)



Kan şekeri kontrolü (hedef 140–180 mg/dL)



Minimal invaziv cerrahi (tercih edilmeli)



Yeterli oksijenasyon ve hemodinamik stabilite



Kan kaybının en aza indirilmesi



Doku travmasının azaltılması ve iyi hemostaz



Amaç: Enfeksiyon riskini azaltmak ve yara iyileşmesini desteklemek.

PREOP BAĞIRSAK BOŞALTIMI (MEKANİK BAĞIRSAK HAZIRLIĞI)



- Safra kesesi cerrahisi için rutin mekanik bağırsak hazırlığı önerilmez.
- Gerekli değilse (ör. kolon cerrahisi eşlik etmiyorsa) sadece sıvı alımı yeterlidir.
- Fayda gösterilmemiştir.



Üst GİS cerrahilerinde tek başına mekanik bağırsak hazırlığı kullanımı CAE riskini azaltmaz.



KAYNAKLAR:

1. Türk Cerrahi Derneği. (2023). Cerrahi alan enfeksiyonları ve profilaksi. Türk Cerrahi Dergisi, 39(2), 65–78.
2. World Health Organization (WHO). Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection. 2018.
3. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. (2025). Cerrahi alan enfeksiyonları. Güncel Konular Kitabı.
4. Ahi Evran Üniversitesi. (2026). Genel cerrahi komplikasyonları. Ders Notları.



2. MİDE AMELİYATI (GASTREKTOMİ / BARIATRİK CERRAHİ)

Mide kanseri, ülser hastalığı veya obezite tedavisi için yapılan cerrahilerdir.

1. YARA TÜRÜ

Temiz-kontamine
(Class II)



Sindirim sistemine kontrollü giriş yapılan cerrahilerde enfeksiyon riski orta düzeydedir.

2. ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ



- Cefazolin 2 g IV + Metronidazol 500 mg IV (anaerob kapsama için) veya
- Tek doz (indüksiyondan 30–60 dk. önce) yeterlidir.



Antibiyotik, insizyondan 30–60 dk. önce verilmelidir. Ek doz genellikle gerekmez.

3. RİSK FAKTÖRLERİ



- Obezite (en güçlü risk faktörlerinden biri)
- Diyabet mellitus
- Malnütrasyon / hipoalbuminemi
- İleri yaş (>65)
- Uzun operasyon süresi (>2 saat)
- İmmünsüpresyon
- Sigara kullanımı



Obez, diyabetik ve malnütrasyonlu hastalarda CAE riski artar.

4. CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU (CAE) ÖNLEME ÖNERİLERİ



Uygun antibiyotik profilaksisi ve zamanlaması



Aseptik cerrahi teknik ve cilt hazırlığı (klorheksidin ile)



Normotermi sağlanması ($\geq 36^{\circ}\text{C}$)



Kan şekeri kontrolü (140–180 mg/dL)



Erken mobilizasyon ve erken enteral beslenme



Doku perfüzyonu için yeterli sıvı ve oksijenizasyon



Nazogastrik tüp kullanımını azaltma

5. BAĞIRSAK BOŞALTIMI (MEKANİK BAĞIRSAK HAZIRLIĞI)



- Üst gastrointestinal sistem cerrahilerinde rutin mekanik bağırsak hazırlığı önerilmez.
- Gerekli değilse (ör. kolon cerrahisi eşlik etmiyorsa) sadece sıvı alımı yeterlidir.
- Fayda gösterilmemiştir.



Üst GIS cerrahilerinde tek başına mekanik bağırsak hazırlığı kullanımı CAE riskini azaltmaz.



KAYNAKLAR:

1. Türk Cerrahi Derneği. (2023). Cerrahi alan enfeksiyonları ve profilaksi. Türk Cerrahi Dergisi, 39(2), 65–78.
2. World Health Organization (WHO). Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection. 2018.

3. Cerrahi Hastalıklar Hemsireliği. (2025). Cerrahi alan enfeksiyonları. Güncel Konular Kitabı.
4. Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society. (2021). ERAS guidelines: foregut surgery.
5. Ahi Evran Üniversitesi. (2026). Genel cerrahi komplikasyonları. Ders Notları.

3. BAĞIRSAK AMELİYATI (KOLOREKTAL CERRAHİ)

Kolon ve rektum cerrahileri
(ör. hemikolektomi, anterior rezeksiyon, abdominoperineal rezeksiyon)

1. YARA TÜRÜ



**Kontamine
(Class III)**

Perforasyon,
anastomoz kaçağı
veya yaygın peritonit
varsa →

Kirli (Class IV)

2. ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ



Önerilen rejimler:

- Sefazolin + Metronidazol (anaerob kapsama için) veya
- Ertapenem (özellikle yüksek riskli hastalarda veya β -laktam alerjisi varsa)



Antibiyotik, insizyondan 60 dk. önce başlanmalı ve 24 saat içinde kesilmelidir.

3. RİSK FAKTÖRLERİ



- Kolonik bakteri yükü (en önemli faktör)
- Diyabet mellitus
- İmmünsüpresyon
- Anemi (Hb < 10 g/dL)
- Malnütrisyon / Hipoalbuminemi
- Obezite
- Acil cerrahi
- Uzun süreli operasyon süresi (> 2 saat)
- Perioperatif kanama
- Perioperatif kan transfüzyonu
- Sigara kullanımı

4. CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU (CAE) ÖNLEME ÖNERİLERİ



Uygun antibiyotik profilaksisi ve zamanlaması



Ellerin uygun şekilde yıkanması ve aseptik teknik



Normotermi sağlanması (>36 °C)



Kan şekeri kontrolü (kan şekeri 140–180 mg/dL)



Minimal invaziv cerrahi tercih edilmesi



Yeterli oksijenasyon ve hemodinamik stabilite



Kan kaybının en aza indirilmesi



Doku travmasının azaltılması ve iyi hemostaz



Amaç: Enfeksiyon kontrolü + doku perfüzyonunu artırarak CAE riskini azaltmak.



KAYNAKLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Cerrahi Alan Enfeksiyonları.
2. World Health Organization (WHO). Global Guidelines for Surgical Site Infection, 2018.
3. Güner, Ş. ve ark. Kolorektal Cerrahide Enfeksiyon Profilaksisi ve ERAS. Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2022; 32(2): 67-78.

Effects of Local Use of Insulin on Wound Healing in Non-diabetic Patients

Plastic Surgery
2018, Vol. 26(2) 75-79
© 2017 The Author(s)
Reprints and permission:
sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/2292550317740688
journals.sagepub.com/home/psg

- DIYABETİK OLMAYAN HASTALARDA LOKAL INSÜLIN KULLANIMININ YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİ İNCELENMİŞ OLUP INSÜLIN UYGULANAN BÖLGEDE YALNIZCA TUZLU SUYA KİYASLA YENİ DAMAR SAYISINDA ANLAMLI FARK GÖZLENMİŞ.



İzmir Tıp Fakültesi Dergisi
Journal of İzmir Faculty of Medicine

Klinik Araştırma

DOI: 10.57221/izmirtip.1286196

İzmir Tıp Fak Derg. 2024;3(1):21-26.

Hemoroid Cerrahisi Öncesi Proflaktik Antibiyotik Tedavisi ve Bağırsak Temizliği Yapılmalı mı?

Should Prophylactic Antibiotic Treatment and Intestine Cleaning be Made Before Hemorrhoid Surgery?

Zeynep Şener Bahçe¹, Tülin Öztaş², Erkan Dalbaş³

- Cinsiyet, operasyon süresi, hastanede kalış süresi, postoperatif analjezik ihtiyacı ve ameliyat sonrası 1.Hafta ve 1. Ayda enfeksiyon açısından açısından fark saptanmamış.
- Hemoroid ameliyatları ameliyat öncesi veya sonrası antibiyotik kullanılmadan ve bağırsak temizliği yapılmadan güvenle yapılabilir.

- Mekanik bağırsak temizliğinin, elektif kolon cerrahisinde rutin olarak uygulanmasından kaçınılmalıdır.
- Mekanik bağırsak temizliği, hastaların dehidratasyon ve ileus gibi komplikasyon oranını arttırmaktadır.

Hastamın bir gün önce eve gitmesini engelleyen sebep nedir?

- Oral mekanik bağırsak temizliğinin, anastomoz kaçağı durumunda **sepsis riskini** azalttığı düşünülmektedir.
- Rollins ve ark. (2018)'nin kolorektal cerrahide bugüne kadar yapılmış en kapsamlı meta-analiz çalışmalarında, ameliyat öncesi yapılan mekanik bağırsak temizliğinin, ameliyat sonrası görülen komplikasyonların insidansında herhangi bir değişikliğe neden olmadığı; ancak mekanik bağırsak temizliğinin kolorektal cerrahide rutin kullanımından kaçınılması gerektiği tavsiye edilmektedir (Rollins ve ark., 2018).



BATIN CERRAHİSİNDE CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ

- Kolorektal cerrahide cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE/SSI) önlenmesi, hasta ve işlem kaynaklı risklerin kontrolü ile mümkündür ve olguların önemli bir kısmının (%60'a kadar) önlenabilir olduğu bildirilmektedir .
- Preoperatif (ameliyat öncesi) önlemler
- Hastaya ameliyat öncesi antiseptik duş (özellikle klorheksidin içeren ürünlerle) önerilmelidir.
- Gereksiz tüy temizliğinden kaçınılmalı; gerekiyorsa elektrikli traş makinesi ile yapılmalıdır.
- İnsizyondan (30–60 dk önce) antibiyotik **profilaksisi** uygulanmalıdır.
- Glisemik kontrol sağlanmalı, hiperglisemi enfeksiyon riskini artırır.
- Malnütrisyon (düşük albümin vb.) düzeltilmeli, çünkü düşük albümin SSI riskini artırır.
- Hastanın komorbiditeleri (koah, diyabet vb.) optimize edilmelidir.



BATIN CERRAHİSİNDE CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ

2. İntraoperatif (ameliyat sırası) önlemler

- Cerrahi alan uygun antiseptiklerle (klorheksidin/alkol bazlı) hazırlanmalıdır.
- Aseptik tekniklere ve cerrahi ekip hijyenine kesin uyum sağlanmalıdır.
- Normotermi korunmalı (hipotermi CAE riskini artırır).
- Operasyon süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır (uzun süre enfeksiyon riskini artırır).
- Uygun oksijenizasyon ve doku perfüzyonu sağlanmalıdır.
- Bağırsak cerrahilerinde fekal kontaminasyonu azaltacak teknikler uygulanmalıdır.



CERRAHI ALAN ENFEKSİYONLARI ÖNLEME GİRİŞİMLERİ ALGORİTMASI

Ameliyat öncesi önleme girişimleri

- Normoterminin sürdürülmesi
 - Hipotermi cerrahi yara enfeksiyonuna duyarlılığı artırır.
 - Subkutan vazokonstriksiyon
 - Doku hipoksisi
 - Nötrofil ve trombosit fonksiyonunda bozulma
- Antimikrobiyal suture
 - Cerrahi türünden bağımsız olarak tüm ameliyatlarda CAE riskini azaltmak amacıyla triklosan kaplı suturelerin kullanılması önerilmektedir.



CERRAHI ALAN ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANSI

"Herhangi bir hastalık, durum veya olay ile ilgili olarak uygun koruyucu ve karşı önlemlerin önerilmesi, alınması ve uygulanması amacıyla verilerin, sürekli ve sistematik bir şekilde toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve ilgili taraflarla paylaşılması"



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSAL
SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ
ENFEKSİYONLAR
SÜRVEYANS TANI REHBERİ

Eylül 2024

SÜRVEYANS TANI REHBERİ



Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların (CAE dahil) tanı, izlem, hesaplama ve raporlama süreçlerini standartlaştırarak enfeksiyonların kontrolünü ve azaltılmasını amaçlar.

1 TANIMLAR VE STANDART KRİTERLER



- SHİE tanımı
- CAE dahil enfeksiyonların tanı kriterleri
- Zaman kriterleri (30-90 gün, implant varsa 1 yıl)

2 ENFEKSİYON TÜRLERİ



- Cerrahi alan enfeksiyonları (CAE)
- Kan dolaşımı enfeksiyonları
- Solunum yolu enfeksiyonları
- Üriner sistem enfeksiyonları

3 SÜRVEYANS (İZLEM) SİSTEMİ



- Aktif / pasif sürveyans
- Hangi hastaların izleneceği
- Taburcu sonrası izlem
- Veri toplama yöntemleri

4 TANİ VE KAYIT KRİTERLERİ



- Klinik bulgular
- Laboratuvar kriterleri
- Standart tanı algoritmaları
- Vaka tanımlama kuralları

5 ORAN VE HIZ HESAPLAMA



- Enfeksiyon hızları
- Yoğunluk oranları (device-associated vb.)
- Risk ayarlama yöntemleri

6 RİSK FAKTÖRLERİ



- Hastaya ait faktörler
- Girişime / cihaza ait faktörler
- Ortama ait faktörler

7 BİLDİRİM VE RAPORLAMA



- Ulusal sistem (UHESA)
- Veri giriş kuralları
- Geri bildirim mekanizmaları

8 ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLEME



El hijyeni

Asepsi /
sterilizasyon

Antibiyotik
kullanımı

İzolasyon
önlemleri

9 KALİTE İYİLEŞTİRME



- Verilerin analizi
- Performans takibi
- Enfeksiyon oranlarını düşürme stratejileri



AMAÇ: Standart tanı ve izlem ile güvenilir veri üretmek, enfeksiyon oranlarını izlemek, geri bildirim sağlamak ve enfeksiyonları önleyerek hasta güvenliğini artırmak.





SONUÇ

- Cerrahi alan enfeksiyonları önlenabilir.
- Hasta güvenliğini tehdit eder.
- Mortalite ve morbiditeyi arttırır.
- Hastanede kalış süresini uzatır

Önlemler

- Risk tanılaması
 - Değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörleri
- Sürveyans



KAYNAK

1. T. C. Mevzuat Bilgi Sistemi, Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği, 2020
2. World health organization. (2018). Global guidelines for the prevention of surgical site infection (2nd ed.). World health organization. World health organization. (2018). Global guidelines for the prevention of surgical site infection (2nd ed.). World health organization.
3. World health organization. (2018). Global guidelines for the prevention of surgical site infection (2nd ed.). World Health Organization.
4. Centers for disease control and prevention. (2023). Surgical site infection prevention guidelines.
5. World Health Organization (2023). Global guidelines for the prevention of surgical site infections.
6. Sarıkaya, B., Ursavaş, F. E. (2025). Kolon cerrahisinde cerrahi alan enfeksiyonları risk faktörleri ve önlenmesinde kanıta dayalı uygulamalar. Avrasya sağlık bilimleri dergisi, 8(3), 210–217.
7. T.C. Sağlık Bakanlığı. (2025). Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı Rehberi.
8. Aydın, o. U., Soylu, L. (2018). Kolorektal kanser cerrahisi sonrası cerrahi alan enfeksiyonu gelişimi için prediktif faktörler. Turkish journal of colorectal disease.
9. Nice. (2020). Surgical site infections: Prevention and treatment.
10. Memikoğlu, K. O. (2014). Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi. 7(2), 250-269.
11. Kangal, M. K. O., Kızılkaya, M. (2025). Physiology wound healing in statpearls statpearls publishing. 3(6), 112-126.





DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM...